

Изделия медицинские полимерные для анестезиологии и реаниматологии.**Фильтр дыхательный.****Инструкция.**

Фильтр дыхательный предназначен для предотвращения инфицирования пациента и дыхательного контура аппарата ИВЛ или наркозного аппарата. Также, при наличии функции теплообмена, возможно использование фильтра без дополнительного увлажнения дыхательной смеси.

Использование фильтра возможно у пациентов, исходя из обозначения на упаковке. На ней указан допустимый Дыхательный объем, при котором фильтр сохраняет свои свойства.

Извлеките фильтр из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Если фильтр поврежден – его использовать нельзя. Подсоедините фильтр к дыхательному контуру между интубационной трубкой/маской/трахеостомической трубкой. Убедитесь, что интубационная трубка и/или контур нигде не перегибаются и не создают препятствий для вентиляции. Периодически проверяйте фильтр на наличие секрета и инородных тел – загрязнение фильтра может привести к повышению сопротивления воздуха и нарушениям вентиляции. Загрязненный фильтр необходимо немедленно заменить. Срок службы фильтра у одного пациента – 24 часа. Также, необходимо менять фильтр после каждого больного.

Контур дыхательный.**Инструкция.**

Контур дыхательный предназначен для доставки дыхательной смеси от аппарата ИВЛ или наркозного аппарата к пациенту. Также, при наличии у аппарата ИВЛ функции теплообмена, возможно использование контура с дополнительным увлажнителем дыхательной смеси.

Использование дыхательного контура возможно у пациентов, исходя из обозначения на упаковке. На ней указан диаметр контура и его длина, что позволяет выбрать необходимый для различных условий (анестезия/реанимация) и видов больных (взрослые/дети/новорожденные).

Извлеките контур из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Если контур поврежден – его использовать нельзя. Подсоедините контур к аппарату ИВЛ или наркозному аппарату. После этого подключите контур к интубационной трубке/маске/трахеостомической трубке. Убедитесь, что интубационная трубка и/или контур нигде не перегибаются и не создают препятствий для вентиляции. Закрепите контур на специальном держателе, если это необходимо. Если контур оборудован влагоборниками, периодически проверяйте в них наличие конденсата. При наличии конденсата, слейте его, отсоединив круговым движением крышку влагоборника от контура, верните крышку на место прежним способом. Периодически проверяйте контур на наличие секрета и инородных тел – загрязнение контура может привести к повышению сопротивления воздуха и нарушениям вентиляции, а также к загрязнению аппарата ИВЛ. Загрязненный контур необходимо немедленно заменить. Срок службы одноразового контура у одного пациента – 24 часа. Также, необходимо менять контур после каждого больного.

Многоразовый контур можно стерилизовать в автоклаве при Температуре 134 °C или оксидом этилена.

Маска наркозная.

Инструкция.

Маска наркозная предназначена проведения ИВЛ и обеспечения оксигенации пациента во время операции.

Использование маски возможно у пациентов, исходя из обозначения на упаковке. На ней указан размер маски, что позволяет выбрать необходимый для различных видов больных (взрослые/дети/новорожденные).

Извлеките маску из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Если маска повреждена – ее использовать нельзя. Подсоедините маску к контуру аппарата ИВЛ или наркозного аппарата. После этого герметично приложите маску к лицу больного и начните вентиляцию. Убедитесь, что маска и/или контур нигде не перегибаются и не создают препятствий для вентиляции. Закрепите контур на специальном держателе, если это необходимо. Необходимо менять маску после каждого больного. Маску можно стерилизовать в автоклаве при Температуре 134 °C или оксидом этилена.

Маска кислородная.

Инструкция.

Маска кислородная предназначена для кислородотерапии пациента.

Использование маски возможно у пациентов, исходя из обозначения на упаковке. На ней указан размер маски, что позволяет выбрать необходимый для различных видов больных (взрослые/дети/новорожденные).

Извлеките маску из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Если маска повреждена – ее использовать нельзя. Подсоедините маску с помощью удлинителя к источнику увлажненного кислорода. После этого герметично приложите маску к лицу больного и начните ингаляцию. Убедитесь, что маска и/или соединительный шланг нигде не перегибаются и не создают препятствий для вентиляции. Закрепите маску на голове пациента с помощью эластичного ремешка, если это необходимо. Необходимо менять маску после каждого больного. Маску можно стерилизовать в автоклаве при Температуре 134 °C или оксидом этилена.

Соединитель.

Инструкция.

Соединитель предназначен для герметичного соединения дыхательного контура и интубационной трубки/маски/трахеостомической трубки пациента.

Использование соединителя возможно у пациентов, исходя из обозначения на упаковке. На ней указан диаметр соединителя и его длина, что позволяет выбрать необходимый для различных условий (анестезия/реанимация) и видов больных (взрослые/дети/новорожденные).

Извлеките соединитель из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений. Если соединитель поврежден – его использовать нельзя. Подсоедините соединитель к контуру аппарата



ИВЛ или наркозного аппарата. После этого подключите соединитель к интубационной трубке/маске/трахеостомической трубке. Убедитесь, что интубационная трубка и/или контур нигде не перегибаются и не создают препятствий для вентиляции. Закрепите контур на специальном держателе, если это необходимо. Периодически проверяйте соединитель на наличие секрета и инородных тел – загрязнение соединителя может привести к повышению сопротивления воздуха и нарушениям вентиляции, а также к загрязнению аппарата ИВЛ. Загрязненный соединитель необходимо немедленно заменить. Срок службы соединителя у одного пациента – 24 часа. Также, необходимо менять соединитель после каждого больного. Многоразовый соединитель можно стерилизовать в автоклаве при Температуре 134 °C или оксидом этилена.

Трубка соединительная тонкая.

Инструкция.

Трубка соединительная тонкая для герметичного соединения измерительного клапана дыхательного контура и измерительного клапана аппарата ИВЛ/наркозного аппарата.

Соедините трубку с измерительным клапаном на контуре пациента и с аппаратом ИВЛ/наркозным аппаратом.

Периодически проверяйте трубку на наличие секрета и инородных тел – загрязнение может исказить данные замера. Загрязненную трубку необходимо немедленно заменить. Трубку можно стерилизовать в автоклаве при Температуре 134 °C или оксидом этилена.

Распылители и комплекты с распылителями.

Инструкция.

Изготовлены из полисульфона, что позволяет проводить стерилизацию паром при температуре до 134 °C без разрушения.

Извлеките распылители из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений, если они повреждены – их использовать нельзя.

Обеспечивает эффективную доставку необходимого количества жидких дыхательных веществ в виде микрочастиц определенного размера. Обеспечивает гибкость респираторной терапии в условиях стационара у детей и взрослых. Генератор аэрозоля не нагревает и не разрушает лекарственные средства.

Увлажнители

Инструкция.

Изготовлены из полисульфона, что позволяет проводить стерилизацию паром при температуре до 134 °C без разрушения.

Конструкция разборная, что позволяет облегчить стерилизацию. Объем камеры – 200 мл. Герметично закрытый клапан позволяет контролировать уровень воды и производить своевременный ее долив. Совместим с различными моделями увлажнителей.

Комплекты фиксации трахеальных трубок.

Инструкция.



Материал изготовления: ПВХ, пенополивинилхлорид.

Комплекты фиксации оснащены гибкой клейкой пенной поверхностью, с помощью которой устройство надежно прикрепляется к коже пациента. Эндотрахеальная трубка надежно удерживается благодаря специально разработанной конструкции пластикового замка, что позволяет так же корректировать положение трубки или ее замену без удаления фиксатора.

Держатели шлангов.

Инструкция.

Не используйте держатели шлангов, если на них имеются механические повреждения.

Изготовлены из ПВХ, что позволяет проводить стерилизацию паром при температуре до 134 °C без разрушения.

Могут использоваться совместно с различными аппаратами ИВЛ. Оснащены эргономичным замком – держателем (с размерами – для контуров диаметром 10, 15, 22 мм.), который позволяет надежно фиксировать дыхательный контур.

Тонкие трубки для мониторинга.

Инструкция.

Материал: полиэтилен. длина 1,5 – 2 м. Коннекторы М/М луер, F/F луер для соединения с дыхательным контуром, фильтром и аппаратом ИВЛ, монитором.

Воздуховоды

Инструкция

Материал: поливинилхлорид, сополимер этилена и пропилена позволяет проводить стерилизацию паром при температуре до 134°C без разрушения.

Гладкая внутренняя поверхность уменьшает сопротивление потоку газовой смеси и уменьшает образование конденсированной влаги при перепаде температур. Внешняя армированная спираль обеспечивают необходимую гибкость контура и препятствует блокировке потока газовой смеси при случайных изгибах. Наличие различных размеров манжет для неонатальных контуров позволяет минимизировать количество адаптеров, что существенно облегчает вес контура. Представленный размерный ряд длины дыхательных трубок контуров позволяет варьировать конфигурации, включая: бактериологические фильтры, кислородные датчики, датчики потока, датчики температуры, влагосборники и т.д. Размерный ряд трубок по диаметру 9 мм, 16 мм, 19 мм обеспечивает комплектацию контуров для всех возрастных групп. Контур имеет вулканизированные манжеты повышенной прочности на излом, что исключает утечку газовой смеси в контуре, облегчает разборку и сборку контуров.

Ручной реанимационный мешок для взрослых с кислородным трубчатым резервуаром

1.



ОПИСАНИЕ.

Ручной реанимационный мешок – это ручной одноразовый



вентилятор для неотложных случаев.

Если прилагается клапан РЕЕР, он снабжен соответствующими метками 5, 10, 15 и 20смH₂O и может быть присоединен напрямую к 30мм порту выдоха.

2. ПОКАЗАНИЯ.

PPM — это устройство для оказания помощи работе легких, предназначенное для дыхательной поддержки пациентов, страдающих от нарушения дыхания. Предназначено для пациентов массой тела от 25кг и больше.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.

Не использовать PPM для пациентов с массой тела менее 25кг.

Если прилагается клапан РЕЕР, не использовать его в анестетических или вентиляционных контурах.

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

4.1. Этим устройством должны пользоваться лишь те медицинские работники, которые должным образом обучены техникам легочной реанимации. Использование этого устройства персоналом, не имеющим соответствующих навыков реанимации, может привести к серьезным повреждениям пациента.

4.2. Только для одноразового использования. Повторное использование может вызвать перекрестное заражение. Стерилизация или чистящие растворы могут привести к задержанию вредных остатков или сделать устройство нефункциональным.

4.3. Если устройство поставляется с маской, то оно сконструировано для совпадения с коннектором только с 22мм внешним диаметром. Внешний диаметр порта маски нестандартный и не должен присоединяться к другим медицинским изделиям.

4.4. Избегать использования устройства в зараженной атмосфере, напр. токсический газ, дым и т.д., что может вредно отразиться на пациенте.

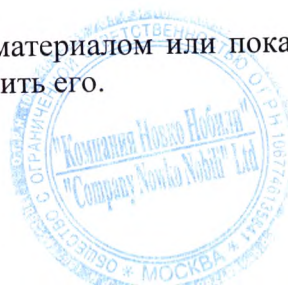
4.5. При использовании вместе с кислородом, избегать любых дымящихся материалов, искр и открытого пламени из-за потенциальной возможности опасного воспламенения.

4.6. Если прилагается фильтр выдоха, то:

- фильтр выдоха может создавать небольшое количество самопроизвольного дыхательного сопротивления при 50л/мин. Не используйте это устройство, если это дополнительное дыхательное сопротивление будет вредным для пациента.

- если дыхательный фильтр закупоривается инородным материалом или показывает чрезмерное сопротивление выдоху, прекратить использование и выбросить его.

4.7. Если прилагается клапан РЕЕР:



5
Alub...

2. проверить установку РЕЕР клапана с помощью манометра и отрегулировать, если необходимо.

6.6. При использовании с дополнительным кислородом:

Присоединить коннектор кислородной трубки (4) к источнику кислорода и отрегулировать подачу кислорода на нужный поток.

6.7. При использовании без дополнительного кислорода:

Атмосферный воздух попадает в устройство через открытый конец трубчатого резервуара (5) при вентилировании без дополнительного кислорода.

6.8. При реанимации через эндотрахеальную или трахеостомическую трубку, присоединить 15мм коннектор к порту пациента РРМ.

6.9. Если в маске появляется кровь или рвотные массы, снять РРМ с пациента и очистить воздушные пути пациента. Быстро сжать мешок для очистки его от всех оставшихся инородных масс. Убрать все закупорки из РРМ, быстро сжимая мешок. Вытряхнуть все оставшееся из маски и гнезда клапана.

6.10. Выбросить РРМ и аксессуары после использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.

Масса тела	25кг или более
Диапазон частот вентиляции*	>32 дыханий в мин @VT=600мл >40 дыханий в мин @VT=375мл
Достижимые давления доставки	не ограничено
Границы рабочей среды	- 18°C до 50°C
Границы среды хранения	- 40°C до 60°C
Входное соединение газа 3.0м трубка подачи кислорода с 6мм ID и (кислородное соединение)	9/16-18 UNF ID фитингом
Соединение пациента	15мм ID на 22мм OD коаксальный коннектор
Максимальный ударный объем	850мл
Мертвое пространство (без маски)	7мл
Сопротивление на выдохе	$\leq$ смH ₂ O (0,5кПа) @50л/мин
Сопротивление на вдохе	$\leq$ смH ₂ O (0,5кПа) @50л/мин
Система ограничения давления	нет



7
Handwritten signature

Внешние размеры РРМ

22см x 35см x 14см

Вес РРМ (без маски)

480гр

Концентрация поставляемого кислорода (%): средние значения

Скорость потока кислорода	5л/мин	10л/мин	15л/мин	15л/мин	15л/мин
Частота	20д/м	12д/м	12д/м	20д/м	12д/мин
Приливный объем	375мл	600мл	600мл	600мл	850мл
Концентрация кислорода	74%	94%	97%	94%	86%



Handwritten signature: Hunkert